Клинические рекомендации

Кисты челюстно-лицевой области и шеи

Конспект для врача-оториноларинголога

Коды МКБ-10	**K04.8** — Корневая киста **K09** — Кисты области рта, не классифицированные в других рубриках **K11.6** — Мукоцеле слюнной железы **L72.0** — Эпидермальная киста **Q18.0** — Пазуха, фистула и киста жаберной щели **Q18.1** — Преаурикулярная пазуха и киста **Q18.2** — Другие пороки развития жаберной щели **Q18.8** — Другие уточненные пороки развития лица и шеи
Пациенты	взрослые, дети
Рекомендация	опубликована в рубрикаторе Минздрава 28.07.2025, пересмотр не позднее 2028 года
Разработчик	Ассоциация общественных объединений "Стоматологическая Ассоциация России"; ООО «Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии»
Полный текст	cr.minzdrav.gov.ru/view-cr/931_1

Конспект клинических рекомендаций Минздрава РФ. Каждый пункт сверен с текстом КР 23.10.2026; неточности самой рекомендации собраны в последнем разделе «Источник и актуальность». Конспект не заменяет полный текст.

Оглавление

1. Основные положения 3

2. Клиническая картина и классификация 3

2.1 Определение 3

2.2 Классификация кист челюстей 3

2.3 Классификация кист мягких тканей 4

2.4 Происхождение кист шеи и околоушной области 4

2.5 Клиническая картина 5

3. Диагностика 5

3.1 Жалобы и анамнез 6

3.2 Осмотр и пальпация 6

3.3 Зондирование и перкуссия зубов 6

3.4 Риноскопия 7

3.5 Лучевые исследования 7

3.6 Осмотр оториноларинголога 7

3.7 Патологоанатомическое исследование 7

3.8 Дифференциальная диагностика 7

4. Лечение 8

4.1 Подготовка зубов 8

4.2 Кисты челюстей 8
4.3 Кисты мягких тканей 9
4.4 Малоинвазивные операции 10
4.5 Профилактика раневой инфекции 10
4.6 Лекарственная терапия 11
4.7 Диета 11
5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации 11
5.1 Показания к госпитализации 11
5.2 Реабилитация 12
5.3 Профилактика и диспансерное наблюдение 12
6. Источник и актуальность 12
6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации 12

1. Основные положения

- Киста — полость с оболочкой из соединительнотканного слоя и эпителиальной выстилки, заполненная жидким или полужидким содержимым. Растёт за счёт давления содержимого: кость рассасывается, челюсть деформируется.
- Консультация оториноларинголога — при кисте верхней челюсти, растущей в полость носа или верхнечелюстную пазуху, и при кисте шеи со свищом в глотку или к корню языка. При кисте мягких тканей шеи осмотр оториноларинголога исключает ларингоцеле.
- Диагноз — кистозная полость в кости или мягких тканях по осмотру и лучевым исследованиям. Окончательный диагноз — гистологический.
- Лечение хирургическое: оболочку кисты удаляют в пределах здоровых тканей.

2. Клиническая картина и классификация

2.1 Определение

Киста — опухолевидное образование: полость, оболочка которой состоит из наружного соединительнотканного слоя и внутреннего, выстланного преимущественно многослойным плоским эпителием. Содержимое — серозная жидкость, гной, коллоиды и кристаллы холестерина.

Продукты эпителиальной выстилки и воспаление повышают давление в полости кисты; кислая среда от гипоксии активирует остеокласты, лизис кости преобладает над её образованием — киста растёт, челюсть деформируется.

2.2 Классификация кист челюстей

Клинико-морфологическая классификация (1975)

1. **Эпителиальные одонтогенные** — первичная (примордиальная кератокиста), киста прорезывания, парадентальная (периодонтальная), десневая, зубосодержащая, фолликулярная, корневая (радикулярная)
2. **Эпителиальные неодонтогенные** — киста резцового канала (носонёбного протока), глобуломаксиллярная (фиссуральная), носогубная (носоальвеолярная, преддверия полости рта), холестеатома
3. **Неэпителиальные** — костные кисты: аневризматическая, травматическая, геморрагическая

Клиническая классификация А. К. Иорданишвили (2000)

1. околозубные: околокорневые, резидуальные, околокоронковые (фолликулярные, кисты прорезывания), ретромолярные (парадентальные);
2. первичная киста (кератокиста);
3. киста носонёбного канала;
4. холестеатомы челюстей;
5. травматические;
6. аневризмальная костная киста;
7. шаровидно-верхнечелюстная киста;
8. носогубная (носоальвеолярная, внекостная).

2.3 Классификация кист мягких тканей

Врождённые

1. аномалии эмбриогенеза: срединные и боковые кисты шеи, кисты околоушной области и корня языка, кисты подъязычной слюнной железы;
2. пороки развития эктодермы: дермоидные и эпидермоидные кисты.

Приобретённые

1. ретенционные кисты сальных желёз (атеромы);
2. травматические;
3. кисты слюнных желёз.

Кисты жаберной щели по Bailey (1929) в модификации Proctor (1955)

Тип	Расположение боковой кисты шеи
I	поверхностно, вдоль передней поверхности грудино-ключично-сосцевидной мышцы, под подкожной мышцей шеи; не соприкасается с влагалищем сосудисто-нервного пучка
II	самый частый: кпереди от грудино-ключично-сосцевидной мышцы и кзади от поднижнечелюстной железы, прилежит латерально к влагалищу сосудисто-нервного пучка
III	между внутренней и наружной сонными артериями, латеральнее боковой стенки глотки
IV	глубже влагалища сосудисто-нервного пучка, в окологлоточном пространстве; открывается в глотку, может распространяться к основанию черепа

2.4 Происхождение кист шеи и околоушной области

Кисты шеи и околоушной области

Киста	Происхождение
Срединная киста шеи	незаращение щитоязычного протока; связана с подъязычной костью и слепым отверстием корня языка, в стенке бывает ткань щитовидной железы
Боковая киста шеи	второй глоточный карман между наружной и внутренней сонными артериями, внутреннее устье — в области нёбной миндалины; лежит на сосудисто-нервном пучке, чаще на уровне бифуркации общей сонной артерии
Киста околоушной области	порок развития первой жаберной щели; латеральнее ствола лицевого нерва, связана с наружным слуховым проходом на границе хрящевого и костного отделов
Киста корня языка	аномалия щитоязычного протока; большая киста перед надгортанником мешает есть и дышать, нагноившаяся похожа на абсцесс корня языка
Лимфоэпителиальная киста	из остатков эпителия в лимфоидной ткани; из второй жаберной дуги — шейная лимфоэпителиальная киста (киста жаберной щели)

2.5 Клиническая картина

Киста челюсти

1. вне обострения симптомов может не быть, иногда — свищ на коже или слизистой;
2. большая киста деформирует челюсть: асимметрия лица, выбухание в полости рта;
3. при пальпации — «пергаментный хруст» или флюктуация;
4. большая киста смещает прорезывающиеся зубы, может привести к перелому нижней челюсти.

Нагноившаяся киста — асимметрия лица от отёка, гиперемия кожи; перкуссия «причинного» зуба обычно болезненна. При нагноении фолликулярной кисты у ретенированного восьмого зуба нижней челюсти бывает затруднено открывание рта.

Срединная киста — по средней линии шеи между слепым отверстием языка и перешейком щитовидной железы. Растёт медленно, безболезненная, гладкая, упругоэластическая; **при глотании смещается только вверх** вслед за подъязычной костью. Кожа над ней не изменена.

Боковая киста — впереди кивательной мышцы на уровне угла нижней челюсти, чаще в юношеском возрасте; округлая, эластическая, смещаемая.

1. **Дермоидная киста** — под языком и в языке, под мышцами дна полости рта, у корня носа, у углов орбиты, в надбровной области; мягкая, с кожей не спаяна
2. **Киста больших слюнных желёз** — безболезненная мягкоэластическая припухлость в околоушно-жевательной или поднижнечелюстной области; из протока — неизменённая слюна
3. **Ранула** — округлое синюшно-прозрачное безболезненное образование подъязычной области; может опорожняться в рот и наполняться снова
4. **Киста малой слюнной железы** — округлое полупрозрачное, иногда голубоватое образование над слизистой, подвижное, безболезненное

При нагноении кисты мягких тканей бывают затруднены глотание, дыхание, движения языка, болезненны повороты головы; возможен свищ с отделяемым.

---

3. Диагностика

Диагноз кисты — кистозная полость в кости или мягких тканях, выявленная при осмотре и инструментальном обследовании, и исключение сходной патологии.

3.1 Жалобы и анамнез

Киста челюсти — выяснить жалобы на

1. вздутие альвеолярного отростка, асимметрию лица;
2. боль, отёк, припухлость тканей;
3. затруднение носового дыхания;
4. снижение чувствительности кожи нижней губы.

В начале киста бессимптомна.

В анамнезе выясняют

1. травму зуба;
2. степень разрушения зубов кариесом;
3. качество эндодонтического лечения;
4. ретенированные зубы.

Киста от центральных резцов верхней челюсти, растущая в нижний носовой ход, даёт постоянную заложенность носа; сдавление носослёзного канала — одностороннее слезотечение.

Нагноившаяся киста челюсти — те же жалобы, плюс повышение температуры тела и озноб. Нагноение кисты, врастающей в верхнечелюстную пазуху, — боль в верхней челюсти и одностороннее отделяемое из носа.

Срединная киста шеи — боль при глотании, болезненность в области языка, ощущение инородного тела при глотании, припухлость в передней области шеи.

Боковая киста шеи — асимметрия шеи, припухлость (иногда болезненная) в верхней трети боковой области шеи, односторонняя боль при глотании.

Дермоидная киста мягких тканей — асимметрия лица и шеи, образование, эстетический дефект, нарушение подвижности языка, глотания, речи.

Нагноившаяся киста мягких тканей лица и шеи — жалобы на

1. боль;
2. асимметрию лица или шеи;
3. отёк, припухлость;
4. затруднение дыхания;
5. повышение температуры тела, озноб.

При воспалении срединной, боковой и дермоидной кисты возможна дисфагия с расстройством речи.

3.2 Осмотр и пальпация

Помимо общего осмотра — наружный осмотр лица и шеи, осмотр полости рта, поверхностная и глубокая пальпация регионарных лимфатических узлов.

Киста челюсти: сглаженность или выбухание переходной складки преддверия рта или нёба; затем «пергаментный хруст» (симптом Рунге — Дюпюитрена), а когда в кости появляется «окно», — флюктуация.

Дермоидная киста дна полости рта: эластичная или тестоватая, гладкая, с чёткими границами; прикреплённая к подъязычной кости — полушаровидное выпячивание в подподбородочной области. Дермоидные кисты околоушной области лежат глубоко, под стволом лицевого нерва или его ветвями.

3.3 Зондирование и перкуссия зубов

Киста челюсти — зондирование, перкуссия и оценка подвижности зубов.

3.4 Риноскопия

Киста носонёбного канала или киста верхней челюсти, растущая в полость носа, при затруднении носового дыхания — риноскопия: определить объём операции и исключить патологию полости носа.

Киста, растущая к нижней стенке грушевидного отверстия, при риноскопии — выпячивание на дне полости носа («валик Гербера»).

3.5 Лучевые исследования

Киста челюсти — рентгенография

1. прицельная внутриротовая контактная;
2. ортопантомография;
3. панорамная рентгенография нижней челюсти;
4. рентгенография придаточных пазух носа;
5. рентгенография нижней челюсти в прямой и боковой проекциях.

Прицельного внутриротового снимка достаточно при околокорневой кисте **не более 7–10 мм**. При кисте **более 11 мм**, у премоляров и моляров нижней челюсти и при наложении анатомических образований — ортопантомография, панорамный снимок, рентгенография пазух.

Если прицельного снимка недостаточно — панорамная рентгенография нижней челюсти, конусно-лучевая томография или КТ челюстно-лицевой области: размеры и топография кисты, состояние слизистой и стенок верхнечелюстной пазухи и полости носа.

Большая киста челюсти — спиральная КТ придаточных пазух носа или КТ челюстно-лицевой области.

Киста мягких тканей лица и шеи — УЗИ мягких тканей и цитологическое исследование материала тонкоигольной аспирационной биопсии: содержимое, размеры, топография.

Если УЗИ недостаточно информативно — МРТ мягких тканей или КТ челюстно-лицевой области.

3.6 Осмотр оториноларинголога

Киста мягких тканей лица и шеи — осмотр оториноларинголога, чтобы исключить ларингоцеле.

3.7 Патологоанатомическое исследование

Всем пациентам — патологоанатомическое исследование операционного материала, чтобы исключить злокачественное образование. Окончательный диагноз — по плановому гистологическому исследованию.

3.8 Дифференциальная диагностика

Кисты челюстей — с амелобластомой, гемангиомой, миеломой, эозинофильной гранулёмой, центральной гигантоклеточной гранулёмой, гигантоклеточной опухолью, фиброзной дисплазией, мягкой одонтомой, хондромой, остеомой, кистой Стафне, саркомой, метастазами карциномы. Помогают КТ, ангиография, сцинтиграфия, цитология пунктата, биопсия.

Кисты околоушной области — с кистами и опухолями околоушной слюнной железы и боковыми кистами шеи; помогают МРТ и цитология пунктата.

Дермоидные и эпидермоидные кисты — с

1. туберкулёзом лимфатических узлов (при первичной форме лёгкие могут быть не поражены);
2. лимфо- и ретикулосаркомой — быстрый рост, множественное поражение узлов;
3. опухолями кроветворной системы;
4. аденолимфомой слюнных желёз — в пунктате клетки опухоли;
5. боковыми и срединными кистами шеи — пунктат дермоидной кисты атеромоподобный, с холестерином;
6. абсцедирующим лимфаденитом;
7. атеромой — дермоидная киста с кожей не спаяна.

Боковые и срединные кисты — с

1. хроническим лимфаденитом шеи;
2. дермоидными кистами;
3. опухолями слюнных желёз (сиалография, МРТ, КТ);
4. каротидной хемодектомой (МР- или КТ-ангиография);
5. метастазами, бранхиогенным раком, лимфо- и ретикулосаркомой, гемангиомой, лимфангиомой;
6. боковые свищи — со свищами после нагноения лимфатических узлов.

Атерому отличают от эпидермоидной кисты, липомы, фибромы, лимфаденита, фурункула, ретенционной кисты по точечной втянутости кожи над протоком железы и спаянности кожи с оболочкой кисты.

---

4. Лечение

Основной метод — хирургический: оболочку кисты удаляют в пределах здоровых тканей.

4.1 Подготовка зубов

Зубы, вызвавшие корневую кисту, — пломбирование корневых каналов и резекция верхушек корней.

Канал пломбируют до операции, до уровня резекции верхушки, **не менее чем на 2/3 длины**.

Зубы, прилежащие к кисте, без реакции на ток при электроодонтометрии, — пломбирование корневых каналов.

Электроодонтометрия, мкА

1. **2–8** — интактный зуб
2. **9–14** — кариес
3. **15–24** — глубокий кариес
4. **25–44** — пульпит
5. **45–80 или нет реакции** — периодонтит

4.2 Кисты челюстей

Перед операцией

1. подписанное согласие пациента;
2. нет хронических заболеваний в стадии декомпенсации и тяжёлых органных дисфункций;
3. выбор метода анестезии, по показаниям — консультация анестезиолога-реаниматолога.

Нагноившаяся киста челюсти — вскрытие и дренирование (цистотомия).

Цистэктомия — полное удаление оболочки кисты; выполняют, если оболочку можно удалить без опасности повредить соседние зубы, сосудисто-нервные пучки, стенки верхнечелюстной пазухи и полости носа. Дефект можно заместить остеопластическими материалами.

Костная пластика — методика по величине дефекта

1. **1/4** — НКР с коллагеновой мембраной, одномоментная имплантация
2. **2/4** — НКР с коллагеновой мембраной, нерезорбируемой мембраной
3. **3/4** — НКР с нерезорбируемой мембраной, титановой сеткой
4. **4/4** — НКР с нерезорбируемой мембраной, титановой сеткой, костные блоки (инлэй, онлэй), дистанционный остеогенез, «Graftless solutions»

НКР — направленная костная регенерация. Классификация остеопластических материалов — в PDF КР, раздел 3.2.

Цистостомия — соустье между полостью кисты и полостью рта.

Показания

1. в полость кисты проецируются **3 интактных зуба и более**;
2. большая киста верхней челюсти с разрушением костного дна полости носа и нёбной пластинки;
3. обширная киста нижней челюсти с истончением основания **менее 0,5 см**;
4. опасность повредить нижнечелюстной сосудисто-нервный пучок;
5. врастание кисты в верхнечелюстную пазуху или полость носа.

Марсупиализация — двухэтапная операция: сначала цистостомия, затем удаление остатков оболочки и свищевого хода. Метод выбора, чтобы снизить травматичность и риск осложнений.

После декомпрессии кость восстанавливается аппозиционным ростом; полость промывают через трубку. Второй этап — в среднем **через 0,5–1,5 года**.

Удаление зуба — если его нельзя вылечить эндодонтически или ретроградно запломбировать.

Удаляют

1. все временные зубы;
2. постоянные «причинные» зубы, если нельзя резецировать верхушку;
3. зубы, корни которых выступают в кисту **более чем на 1/2**;
4. подвижность и атрофия альвеолярного отростка больше II–III степени;
5. коронка разрушена и не восстанавливается;
6. значительное искривление корней.

Киста челюсти, проникающая в верхнечелюстную пазуху, — цисториносинусостомия: удаление оболочки кисты с радикальной операцией на пазухе, сообщение с нижним носовым ходом; при эндоскопической операции расширяют естественное соустье.

Показания

1. интрасинусальная киста оттесняет дно пазухи вверх **на 1/3 высоты и более** (средняя и большая);
2. малая интрасинусальная киста с резким истончением костной перемычки — высок риск перфорации дна пазухи.

4.3 Кисты мягких тканей

Нагноившаяся киста мягких тканей лица и шеи — цистотомия или пункция с эвакуацией гноя.

Срединная киста шеи — экстирпация кисты и свища **с резекцией тела подъязычной кости**. Лечение только хирургическое.

Под эндотрахеальным наркозом, горизонтальный разрез по кожной складке на уровне подъязычной кости; кисту выделяют тупо, не повреждая оболочку. Тело подъязычной кости резецируют клиновидно, **на 0,5 см** в обе стороны от свищевого хода.

Боковая киста шеи — цистэктомия. Лечение только хирургическое.

Под эндотрахеальным наркозом; разрез по переднему краю грудино-ключично-сосцевидной мышцы (безопаснее) или по верхней шейной складке (косметичнее). Резиновый выпускник удаляют **на 2–3-и сутки**.

Киста подъязычной слюнной железы — цистэктомия.

Чтобы снизить риск рецидива — марсупиализация или цистэктомия с удалением подъязычной или поднижнечелюстной слюнной железы.

Марсупиализация — при большой рануле или повреждении оболочки: иссекают купол кисты, стенку подшивают к слизистой, в полость — турунда.

4.4 Малоинвазивные операции

Старше 16 лет: боковая киста шеи без свищевого хода, дермоидная киста боковой области шеи — при наличии оборудования видеоэндоскопическое или роботассистированное удаление.

Под эндотрахеальным наркозом; заушный доступ (RAHI, face-lift) или тоннельный доступ из разреза в волосистой части затылочной области. Вакуумный дренаж удаляют **на 1–2-е сутки**.

Старше 16 лет: киста поднижнечелюстной слюнной железы — видеоэндоскопическая или роботассистированная цистэктомия либо цистэктомия с удалением железы.

4.5 Профилактика раневой инфекции

Перед операцией — профилактика инфекционных осложнений в области хирургического вмешательства; по показаниям — обезболивание и противоотёчная терапия.
Антибиотикопрофилактика — по национальным рекомендациям «СКАТ», «НАСКИ».

Антибактериальный препарат системного действия — в разовой терапевтической дозе.

Повторная интраоперационная доза — если операция дольше **двух периодов полувыведения** препарата или при массивной кровопотере.

Однократное введение; при продлении профилактики препарат отменяют **не позднее 24 часов** после операции, даже если стоит дренаж.

При длительном сообщении раны с полостью рта профилактику можно продлить **до 48, максимум 72 часов**.

Разрабатывать локальные протоколы антибиотикопрофилактики.

Антибиотикопрофилактика

Операция	Препараты выбора	Альтернатива	Категория
Нет риска сообщения раны с полостью рта («чистая рана»)	не рекомендуется	не рекомендуется	B
Риск сообщения раны с полостью рта или околоносовыми пазухами	цефазолин + метронидазол или амоксициллин + клавулановая кислота	клиндамицин	A

1. цефазолин + метронидазол — внутривенно детям **с 1 месяца**, дозы по инструкции; взрослым **2 г** цефазолина + **500 мг** метронидазола **за 60 минут** до операции;
2. клиндамицин — взрослым **600–900 мг** внутривенно перед операцией;
3. амоксициллин + клавулановая кислота — внутривенно взрослым и подросткам **старше 12 лет**, дозы по инструкции.

Цефазолин, метронидазол и клиндамицин в КР отмечены знаком # — применение вне инструкции.

Инфицированная рана (застарелая травма, предшествующая инфекция, гной, нежизнеспособные ткани) — антибактериальную терапию начинают до операции.

После операции — терапевтические дозы с учётом веса, возраста, функции почек и печени, тяжести инфекции, риска резистентности и локальных микробиологических данных; при инфицированной ране — микробиологическое исследование. Препараты выбора — группы: комбинации пенициллинов с ингибиторами бета-лактамаз, другие бета-лактамы, ко-тримоксазол, линкозамиды, аминогликозиды, фторхинолоны, гликопептиды, производные имидазола, прочие.

4.6 Лекарственная терапия

Обезболивание — анальгетики и НПВП с учётом противопоказаний и возрастных ограничений.

Нарушена целостность стенок верхнечелюстной пазухи или была операция в области носа — после операции деконгестанты и другие назальные препараты: уменьшить отёк слизистой пазухи и соустья, улучшить дренаж, предупредить воспаление.

По показаниям — противоотёчная терапия глюкокортикоидами.

Местно — антисептики и дезинфицирующие средства для профилактики инфекционных осложнений.

4.7 Диета

Киста нижней челюсти — челюстная диета: снизить риск патологического перелома и нагноения.

Киста подъязычной, поднижнечелюстной или околоушной слюнной железы — исключить слюногонную пищу.

---

5. Профилактика и диспансерное наблюдение. Показания к госпитализации

5.1 Показания к госпитализации

Небольшая киста (**менее 3 зубов**) — амбулаторно.

Госпитализация

1. небольшая киста при тяжёлой сопутствующей патологии;
2. киста **более 3 зубов**;
3. нагноение — экстренно, в остальных случаях планово.

Выписка

1. острое воспаление купировано;
2. нет риска послеоперационного кровотечения.

5.2 Реабилитация

После операции — многоэтапная реабилитация до полного социального и физического восстановления.

Ежедневные осмотры и перевязки, швы снимают **на 7–10-й день**. Койко-день до операции **0–2**, после — **4–10**. После цистотомии и цистэктомии йодоформный тампон меняют **через 5–6 дней**, до 3–4 раз; к концу 3-й недели рана эпителизируется, полость пациент промывает сам. Полость уменьшается за счёт роста кости **за 1,5–2 года**.

Инфицирование сгустка — отток экссудата между швами и промывание полости антисептиками; ежедневные промывания **3–4 дня** обычно купируют воспаление. Если гной сохраняется — рану раскрывают, в полость вводят йодоформный тампон до гранулирования (**2–3 недели**).

5.3 Профилактика и диспансерное наблюдение

При первых симптомах кисты челюсти или мягких тканей — консультация стоматолога-хирурга. Профилактика воспалительных одонтогенных кист — своевременное лечение осложнённого кариеса и перикоронита.

Пломбирование зубов в зоне радикулярной кисты — накануне или перед операцией. Парадентальные, фолликулярные и первичные кисты — контроль **через 6 месяцев** после цистэктомии и до восстановления кости; при фолликулярных и парадентальных — наблюдение ортодонта.

При первых симптомах кисты мягких тканей — УЗИ мягких тканей шеи.

Киста верхней челюсти, растущая в полость носа или верхнечелюстную пазуху, — консультация оториноларинголога.

Киста мягких тканей шеи со свищевым ходом в области глотки или корня языка — консультация оториноларинголога.

На исход влияют отрицательно

1. инфекционные осложнения;
2. нарушение ограничительного режима в раннем послеоперационном периоде;
3. нарушение диеты.

---

6. Источник и актуальность

Документ	Клинические рекомендации «Кисты челюстно-лицевой области и шеи»
Версия	1-я, опубликована в рубрикаторе 28.07.2025
Статус	**Применяется** (каталог рубрикатора на 22.10.2026)
Актуализация	По общему правилу КР пересматривают не реже раза в три года, следующая версия ожидается не позднее июля 2028 года
Код в рубрикаторе	931_1 · открыть текст КР ↗
Разработчик	Общество специалистов в области челюстно-лицевой хирургии; Стоматологическая Ассоциация России
Пациенты	Взрослые и дети

6.1 Неточности и противоречия в тексте рекомендации

- Для кисты челюсти в разделе 3.2 сразу три операции названы оптимальными: цистэктомия — «как наиболее оптимального», цистостомия — «как наиболее оптимального», марсупиализация — «как метод выбора». Выбор — по показаниям из комментариев.
- Антибиотикопрофилактику рекомендовано отменять не позднее 24 часов после операции, а комментарий допускает продление до 48–72 часов.

- В таблице антибиотикопрофилактики категории рекомендаций A и B, а сами рекомендации раздела 3.5 — C, 5.
- Текст PDF — скан с ошибками распознавания; цитаты журнала сверки приведены по распознанному тексту, таблицы сверены по изображениям страниц 28 и 35.